

Carcinoma Espinocelular (CEC)

(Basado en Guías MINSAL Chile 2023, NCCN Guidelines 2024, American Academy of Dermatology 2024, British Association of Dermatologists 2023, Fitzpatrick's Dermatology 2023, y UpToDate 2025).

1. Introducción y relevancia clínica

El **carcinoma espinocelular cutáneo (CEC)** es el **segundo cáncer de piel más frecuente** después del carcinoma basocelular.

A diferencia de este último, el CEC **posee potencial metastásico**, especialmente cuando compromete labios, orejas o mucosas.

Se origina a partir de **queratinocitos de la epidermis** que adquieren mutaciones inducidas por **radiación ultravioleta crónica** u otros agentes carcinogénicos.

Aunque su mortalidad es baja, puede ser **agresivo y destructivo localmente**, con riesgo de invasión ganglionar o metastásica si no se trata oportunamente.

Relevancia clínica

- Representa cerca del **20% de los cánceres cutáneos**.
 - Tiene un **potencial maligno real**, a diferencia del carcinoma basocelular.
 - Es un **marcador de daño actínico acumulado**.
 - En el EUNACOM, se pregunta con frecuencia su **diferenciación clínica con el CBC**, su **manejo quirúrgico con márgenes amplios**, y los **factores de riesgo de metástasis**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Origen celular

El CEC se origina en los **queratinocitos suprabasales** de la epidermis, donde ocurre una secuencia progresiva de mutaciones y displasias, que evolucionan desde **queratosis actínica** → **carcinoma in situ (enfermedad de Bowen)** → **carcinoma invasor**.

2.2. Mecanismo patogénico

- **Radiación UVB:** induce mutaciones del ADN (gen p53 y RAS).
 - **Inflamación crónica:** úlceras, cicatrices o radiodermatitis.
 - **Inmunosupresión:** inhibe vigilancia inmunológica antitumoral.
 - **Virus oncogénicos (VPH tipos 16, 18):** especialmente en mucosas genitales y perianales.
-

2.3. Factores de riesgo

Categoría	Ejemplos
Ambientales	Exposición solar crónica, quemaduras, radiación ionizante, arsénico
Cutáneos	Queratosis actínica, leucoplasia, úlceras crónicas, cicatrices
Inmunológicos	Trasplantes, VIH, tratamiento inmunosupresor
Genéticos	Xeroderma pigmentoso, albinismo oculocutáneo
Infecciosos	VPH en zona anogenital
Otros	Tabaquismo (labios), lesiones en mucosa oral o genital

2.4. Tipos histológicos principales

Tipo	Descripción	Riesgo
Bien diferenciado	Nidos de queratinocitos con perlas córneas	Bajo
Moderadamente diferenciado	Menor queratinización, mitosis más frecuentes	Intermedio
Pobrementemente diferenciado	Células anaplásicas, alto índice mitótico	Alto

Otros subtipos clínicos incluyen el **queratoacantoma** (forma de crecimiento rápido y a veces autolimitada), y el **CEC verrucoso**, de crecimiento exofítico lento.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Lesión típica

- **Pápula, nódulo o placa indurada**, eritematosa, de superficie **costrosa o ulcerada**.
- Evolución **rápida** en semanas o meses.
- Puede ser **dolorosa o sangrante**.
- En labios y orejas tiende a ser más agresiva.

Textura: firme, dura, a diferencia del CBC, que es más blando y perlado.

Bordes: mal definidos o sobreelevados con úlcera central.

3.2. Localizaciones más frecuentes

- Cara: labio inferior, pabellón auricular, dorso de nariz.
- Cuero cabelludo calvo.
- Dorso de manos y antebrazos.

- Mucosas: cavidad oral, lengua, genitales externos.
 - En Chile, alta incidencia en **labio inferior y pabellón auricular** por exposición solar.
-

3.3. Formas clínicas principales

Subtipo	Descripción
Clásico ulcerado	Placa costrosa, infiltrada, con borde indurado
Queratoacantoma	Nódulo hemisférico con tapón córneo central, crecimiento rápido
Verrucoso	Lesión exofítica, superficie papilomatosa
In situ (enfermedad de Bowen)	Placa eritematosa descamativa, sin invasión dérmica

3.4. Diagnóstico diferencial

Lesión	Diferencias clave
Carcinoma basocelular (CBC)	Pápula perlada, crecimiento lento, sin costra, sin dolor
Queratosis actínica	Placa rugosa, sin invasión dérmica, tamaño pequeño
Queratoacantoma	Nódulo rápido, con tapón córneo, crecimiento inicial brusco

Melanoma amelanótico	Lesión eritematosa sin pigmento, crecimiento rápido, sin queratina
Infecciones crónicas	Úlceras de base sucia, sin induración marcada

3.5. Signos de alarma

- Dolor persistente o crecimiento rápido.
 - Induración, ulceración profunda o sangrado espontáneo.
 - Lesiones en labios, pabellón auricular o mucosas.
 - Adenopatías regionales palpables (metástasis).
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico es **sugerido clínicamente** y **confirmado por biopsia**.

4.2. Dermatoscopía

Hallazgos típicos:

- Escamas o costras amarillentas.
 - Vasos punteados o glomerulares.
 - Estructura desorganizada.
 - En CEC queratinizante: tapones córneos y ulceración.
-

4.3. Biopsia

Confirmatoria y obligatoria.

- Tipo incisional o punch si extensa.
- Escisional si pequeña.

Hallazgos histológicos:

- Invasión de queratinocitos atípicos más allá de la membrana basal.
 - Perlas córneas ("keratin pearls").
 - Mitosis frecuentes.
-

4.4. Estudios de extensión

Indicados en:

- Tumores >2 cm, mal diferenciados, mucosos o recidivantes.
- Adenopatías palpables.

Exámenes:

- Ecografía ganglionar.
 - TC o RMN (invasión profunda).
 - Biopsia de ganglio centinela en casos de alto riesgo.
-

4.5. Clasificación pronóstica (NCCN / AJCC 2024)

Factores de alto riesgo de recurrencia o metástasis:

- Tamaño >2 cm.
- Grosor >2 mm o invasión a grasa.
- Mal diferenciación histológica.
- Perineural o vascular.

- Localización: labio, oreja, cara central, genitales.
- Paciente inmunosuprimido.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile, 2023)

5.1. Objetivos

- Erradicación completa.
- Prevención de recurrencias y metástasis.
- Preservar función y estética.

5.2. Tratamiento quirúrgico (de elección)

Tipo de lesión	Tratamiento recomendado	Márgenes quirúrgicos
CEC bajo riesgo	Escisión simple	4–6 mm
CEC alto riesgo	Cirugía de Mohs o márgenes ampliados	≥10 mm
CEC in situ (Bowen)	Escisión o crioterapia / Imiquimod tópico	4 mm
CEC mucoso o con invasión ósea	Resección amplia + radioterapia adyuvante	Individualizado

La cirugía de Mohs permite evaluar márgenes en tiempo real y es el estándar para tumores de alto riesgo o en zonas críticas (cara, nariz, párpado, labios).

5.3. Tratamientos complementarios

Modalidad	Indicaciones	Comentarios
Radioterapia	Pacientes inoperables o márgenes positivos	Buena alternativa en ancianos
Imiquimod 5% tópico	CEC in situ o superficial	Menor eficacia que cirugía
Terapia fotodinámica (ALA + luz roja)	Bowen, lesiones superficiales	Estética favorable
Curetaje y electrocoagulación	Tumores pequeños, bien delimitados	No en áreas estéticas
Quimioterapia sistémica (cisplatino, 5-FU, cetuximab)	Metastásico o localmente avanzado	Uso hospitalario especializado

5.4. Seguimiento

- Control dermatológico cada **3–6 meses** durante 2 años.
 - Luego **anual de por vida**.
 - Palpación ganglionar en cada control.
 - Educación en **autoevaluación cutánea** y **fotoprotección diaria**.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
--------------	-------------

Recurrencia local	Si márgenes incompletos o tipo agresivo
Metástasis linfática	2–5% en piel, hasta 20% en mucosas
Metástasis a distancia	Pulmón, hígado, hueso
Invasión perineural	Causa dolor y recidiva
Desfiguración facial	En zonas de difícil manejo quirúrgico

Pronóstico global:

- CEC cutáneo bien tratado → supervivencia >95%.
- CEC de alto riesgo o mucoso → supervivencia 60–70%.
- Mortalidad aumenta en inmunodeprimidos.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **CEC = lesión costrosa, dolorosa, indurada, de crecimiento rápido.**
2. Principal diferencia con CBC: **CEC duele, crece rápido y puede metastatizar.**
3. Se origina en **queratosis actínicas o cicatrices crónicas.**
4. El **tratamiento de elección es quirúrgico**, con márgenes amplios.
5. En **mucosas (labio inferior, genitales)** → alto riesgo de metástasis.

6. **Queratoacantoma** es una variante benigna o autolimitada, pero se maneja igual que CEC por precaución.
 7. **Radioterapia** es alternativa válida en ancianos o inoperables.
-



Errores comunes

- Confundirlo con CBC y subestimar su agresividad.
 - No realizar biopsia ante una úlcera persistente.
 - Tratar con crioterapia sin diagnóstico histológico.
 - No ampliar márgenes en tumores de alto riesgo.
 - Ignorar adenopatías regionales.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **carcinoma espinocelular** es un **cáncer cutáneo maligno derivado de queratinocitos**, con potencial metastásico.
2. Su **lesión típica** es una **placa o nódulo ulcerado, costroso e indurado**, en zonas fotoexpuestas.
3. Factores de riesgo: **sol crónico, queratosis actínica, inmunosupresión, VPH**.
4. El **diagnóstico se confirma con biopsia**, y el **tratamiento de elección es quirúrgico con márgenes amplios**.
5. Requiere **seguimiento prolongado** por riesgo de recurrencia o nuevos cánceres.
6. A diferencia del CBC, el CEC **puede metastatizar y crecer rápidamente**.
7. En **EUNACOM**, recordar:
 - CBC → perlado, lento, sin dolor.

- CEC → costroso, rápido, doloroso.
- Melanoma → pigmentado, irregular, cambiante.